

過敏症・インフュージョンリアクション

投与前と帰宅後を薬局で支える

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬
溶媒・薬剤への過敏症

タキサン系(初回・2回目) バクリタキセル ドセタキセル
 白金製剤(回数を重ねて) カルボプラチン オキサリプラチン シスプラチン
 その他 L-アスパラギナーゼ エトポシド

抗体薬・ADC
インフュージョンリアクシ
ョン

初回に多い リツキシマブ セツキシマブ アミバンタマブ ダラツムマブ
 その他の抗体薬・ADC トラスツマブ ラムシルマブ T-DM1

T細胞を活性化する治
療
サイトカイン放出症候群
(CRS)

二重特異性抗体 エブコリタマブ テクリスタマブ タルラタマブ CAR-T細胞療法 (専門施設で実施)

予防に使う薬(前投薬)
反応を予防・軽減

抗ヒスタミン薬 d-クロルフェニラミン ジフェンヒドラミン ステロイド デキサメタゾン
 解熱鎮痛薬・H2遮断薬 アセトアミノフェン ファモチジン

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 重症度(CTCAE Grade)と保険薬局での対応

軽い — 重症度 — 重い

Grade1

注入に伴う反応
軽度で一過性、点滴の中断・治療を要さない

アレルギー反応
全身的な治療を要さない

保険薬局での対応
症状を記録し、次の投与に向けて病院へ共有

Grade2

注入に伴う反応
点滴の中断・治療を要するが速やかに改善、予
防投薬を要する

アレルギー反応
内服治療を要する

保険薬局での対応
遅発性の皮疹・発熱を聴取し、情報提供書で共
有

Grade3

注入に伴う反応
遅延・再発する、入院を要する

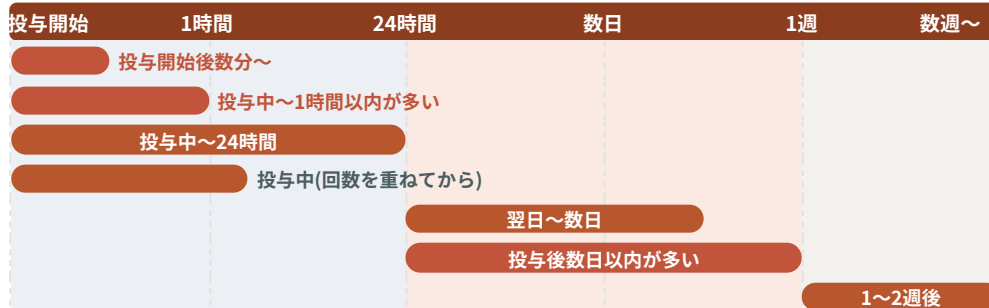
アレルギー反応
気管支痙攣、入院・静脈内投与の治療を要する

保険薬局での対応
帰宅後の呼吸困難・意識の変化は救急受診

帰宅後に起こる遅発性の反応(発熱・皮疹・だるさ)もあるため、投与当日の夜から翌日の症状を聞き取る

3 副作用の特徴と発現時期

- タキサン系の過敏症
- アナフィラキシー
- インフュージョンリアクション
- 白金製剤の過敏症
- 遅発性の発熱・皮疹
- CRS(二重特異性抗体・CAR-T)
- 血清病様反応(まれ)



☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

1. タキサンは初回・2回目、白金製剤は回数を重ねてから、抗体薬は初回に多い
2. 前投薬の服用時間と、アレルギー歴・前回の反応の共有は薬局の役割
3. 帰宅後の遅発性の反応・CRSを電話で確認し、息苦しさは救急受診へ